



детские реабилитологи национальная ассоциация

[Поиск](#)[Как вступить?](#)[Войти](#)

Формирование тазобедренных суставов после реконструктивных вмешательств

Специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова» МЗ РФ провели исследование, посвященное изучению изменений рентгеноанатомических параметров формирования тазобедренного сустава после реконструктивных вмешательств.

В исследовании приняли участие 49 детей, которым выполнялись реконструктивные вмешательства подвывиха или вывиха бедра с периодом наблюдения после операции не менее трех лет. Все пациенты имели ДЦП, согласно классификации глобальных моторных функций (GMFCS), 30 — относились к IV уровню, 19 — к V уровню.

В зависимости от показаний пациентам выполнялась деротационно-варизирующая остеотомия (ДВО) (28 пациентов, 44 сустава, средний возраст на начало лечения $6,98 \pm 2,2$ года) или ДВО в сочетании с ацетабулопластикой (АП) (21 пациент, 38 суставов, средний возраст на начало лечения $7,0 \pm 2,04$ года). Одновременно проводилось вмешательство на уровне коленного и/или голеностопного сустава и коррекция деформаций стопы.

Для определения влияния отдельно выполненной деротационно-варизирующей остеотомии или ДВО в сочетании с ацетабулопластикой на развитие тазобедренного сустава было произведено сравнение динамики изменений ацетабулярного угла, индекса Reimers, индекса фронтальной глубины впадины, угла Wiberg по рентгенограммам таза, выполненным в прямой проекции в период до операции, непосредственно после вмешательства и через 1, 2 и 3 года после операции.

В отдаленном периоде у исследуемой авторами группы пациентов отмечалась одинаковая тенденция по сохранению правильных взаимоотношений головки бедра и вертлужной впадины, а также стабилизация или улучшение показателей параметров, иллюстрирующих развитие вертлужной впадины (индекс Wiberg, AI и ИФГВ).

Авторы отметили среднее увеличение индекса Reimers не более 3 % в год после ДВО и не более 2 % в год после ДВО в сочетании с ацетабулопластикой. Bayusentono et al., что указывают на увеличение миграционного индекса на 2 % для GMFCS IV и 3,5 % для GMFCS V в послеоперационном периоде сопровождалось стабилизацией других рентгеновских

параметров коксометрии, при этом рецидивы подвывихов/вывихов бедер не наблюдались.

В данной серии пациентов также не отмечены рецидивы данного осложнения ДЦП на протяжении наблюдения в течение 3-х лет. Как показывает данное исследование, подход с выполнением многоуровневых вмешательств, включая реконструкцию тазобедренного сустава, у данной группы пациентов находит свое оправдание и точки зрения создания благоприятных условий для проведения постурального менеджмента в послеоперационном периоде.

При выполнении ДВО без ацетабулопластики на протяжении 3-х лет наблюдения отмечалось прогрессивное уменьшение АИ в сравнении с послеоперационными параметрами, что также сопровождалось ростом значений угла Wiberg. После ДВО в сочетании с АП на протяжении 3-х лет наблюдения отмечалась противоположная тенденция к прогрессивному увеличению АИ до нормальных возрастных значений в отличие ситуации, наблюдаемой после выполнения только ДВО. В любом случае, в первом, так и во втором варианте выполнения реконструктивной операции происходит нормализация рентгеноанатомических параметров и их последующее изменение в пределах нормальных значений соответствующего возраста, что отражает благоприятное развитие тазобедренных суставов.

Корреляция «АИ – угол Wiberg» после ДВО носит обратный умеренный и заметный характер, являясь статистически значимой. Для вмешательств, объединяющих ДВО и ацетабулопластику, теснота корреляционной связи высокая обратная, статистически значимая. Это указывает на благоприятный характер и направление развития оперированных тазобедренных суставов в отдаленном периоде после реконструктивных вмешательств для обеих групп. При изучении корреляции величины относительных изменений и возраста выполнения операции обнаруженная умеренная теснота связи лишь для изменений АИ после ДВО на третьем году после операции и для изменений угла Wiberg также на третьем году наблюдения свидетельствует в пользу незначительного влияния возраста в рамках изучаемой группы пациентов на развитие тазобедренного сустава после многоуровневых вмешательств.

Очевидно, что после устранения дислокации бедра хирургическим путем нужно продолжать интенсивный контроль сохранения и поддержания условий для правильного развития тазобедренного сустава, используя потенциал остаточного роста и ремоделирования его суставных концов. Именно с этой точки зрения выполнение одновременного с реконструкцией тазобедренного сустава устранения контрактур коленного и голеностопного суставов и коррекция деформаций стоп помогает создать благоприятные условия для постурального менеджмента и пассивной вертикализации пациентов с осевой нагрузкой на конечности.

Источник: [«Рентгеноанатомия формирования тазобедренных суставов после реконструктивных вмешательств у детей со спастическими параличами»](#)

А.Д. Томов, М.П. Тепленький, А.М. Аранович, Г.М. Чибиров, Д.А. Попков

[Том 26, № 1 \(2020\)](#)

Метки: [научные исследования](#), [ортопедия](#), [травмотология](#)

17.04.2020

[ейропсихологическая коррекция ВПФ у детей с легкой степенью умственной отсталости](#)
[сследование кардиоваскулярных факторов риска у детей с наследственной отягощенностью](#)



Как вступить?



© 2022 Национальная ассоциация детских реабилитологов